

TEMA 4.13 • DERMATOLOGÍA

Eccema Dishidrótico

PERFIL EUNACOM 6.01.1.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Eccema Disidrótico (Ponfólix o Disidrosis)

El Eccema Disidrótico, referenciado clínicamente en Dermatología también bajo sus sinónimos de uso médico constante "*Disidrosis, Ponfólix, o Eccema Palmo-Plantar Agudo*", asume la clasificación dentro del gigantesco abanico que entraña al grupo de todas aquellas inflamaciones tisulares referenciadas coloquialmente como "Eccemas" (que es sencillamente una palabra sinónima clínica integral para etiquetar a toda dermatitis inespecífica).

Fisiopatogenia y Base Desencadenante

Su desarrollo subyace tras una intensa interrelación sistémica cruzada fuertemente **Multifactorial**. - Existe predisposición genética atópica inmunológica latente innata en el sujeto base, lo cual se detona súbitamente ante una sumatoria exacerbada en picos de crisis de reactivadores como una Invasión ambiental Alérgica sistémica (Ej. polen, mascotas), o el paralelo roce exacerbado derivando por reacciones cruzadas de secundarias por **Dermatitis de Contacto alérgicas** contiguas directas generalizadas de fondo a otros contactantes. - En una proporción inmensa, este episodio inflamatorio desata íntima e inseparablemente su brote explosivo atado al altísimo índice desencadenante de **Estrés Psicosocial e Inestabilidad Ansiosa aguda que cataliza el episodio en un corto plazo fulminante general**.

Cuadro Clínico Morfológico del Estallido Eruptivo (Ponfólix)

- **El Patrón Evolutivo Clínico:** Entabla patognomónicamente un perfil de decursar clínico **Recidivante Intermitente Crónico:** Asedia alternándose con la invasión de episodios o crisis repetitivas brutales asintomáticas separadas intercaladas mediando un largo plazo normal asintomático silente limpio o inter-crisis transitorias de remisión parcial y meses controlados tranquilos, hasta estallar repetidas veces con gran desproporcionalidad. - **La Lesión Específica:** Aparición brusca repentina paralela de **Vesículas (Abolladuras minúsculas con contenido seroso cristalino inmaculado)** que se palpan profundamente enclavadas y de superficie dura esférica como **"Tensas / en Semillas de Tapioca/arroz"**. En casos inusuales se aglomeran reventándose como **Amplas gigantescas y graves Bulas**. - **El Rasgo Sintomatológico Clave Torturoso:** Ocasionan universal e indeteniblemente dolor pero lo eclipsa inmensamente su extrema asediante cruzada de **Trastornarse patognomónicamente hiper-pruriginoso desproporcional insostenible**. (Ocasiona desesperación letal que insta rotura por rascado afilado para el alivio del escozor extremo tenso). - **Cartografía Clásica Limitada Excluyente:** Focaliza, como el título "palmo-plantar" indica, en extremidades limítrofes netas exclusivas como lo son: Asediando por caras externas colapsantes perimetrales en los **Bordes laterales de Los Dedos y general a las Palmas de las Manos firmemente en paralelo estricto en idéntico caso en la planta acral anatómica a los Pies íntegramente de contacto dactilar inferior**. (Raramente salta pero puede saltar el dorso superficial externo).

Protocolo Terapéutico Dermatológico Rescatador

- **Medida N°1 Basal Primaria Terapéutica Generalizada Causal:**
Interrumpir precipitantes externos limitando con el riguroso

encausamiento conductual para la Evitación rotunda educada directa al agente Alérgico / Estrés. Y la mantención sistémica controlada pasiva paralela al factor psicológico integral ansiolítico del brote.

- **El Pilar de Oro Manejo Medicamentoso EUNACOM:** Constituyen un control apacitador y retroceso brutal curativo espectacular frenatorio rápido al aplicarse imperativamente con uso general los embates inflamatorios desde el minuto inicial del re-debut fásico para lograr evitar escalar el brote mediante los potentes limitantes locales agresivos frotados: **Los Corticoides Tópicos frotados en zona de extremada Alta Potencia generalizados basales (Ej. el pilar base con Clobetasol o la Betametasona local a libre estante en capa untados fuertes rápidos por encima)**. Ocasionalmente como línea cruzada se suman Tacrolimus en esquemas largos por inmunomodulador local.
- **Tratamiento Crítico Severo Excepcional Limitante Invalidador Intratable Hospitalario:** Si las bullas estallan y desproporcionan reventando gigantescas plantas en pies impidiendo a causa del insostenible dolor el mero poder Caminar o flete en su dolor paralizante del andar sin solución rápida curativa ambulatoria tópica que fracasa; instaura y asciende al derivar la indicación inminente superior corticoidea cruzada al apagar de forma masiva internamente estricta corta con pulsos directos de los desinflamatorios al paciente recitando el **Uso Obligatorio momentáneo de Corticoides Sistémicos en píldoras (Vía Oral con Prednisona temporal pauta de reducción progresiva)** o si falla derivación al tratamiento oncológico pasivo ultravioleta sistémico cruzado (La Fototerapia de largo uso restrictivo y seguimiento hospitalario general PUVA).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Cuál es la localización característica de las vesículas del eccema dishidrótico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Eccema Dishidrótico. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El eccema dishidrótico produce vesículas tensas profundas muy pruriginosas en palmas, plantas y dedos.
- Las vesículas son tensas porque se ubican en la capa córnea gruesa de palmas y plantas.
- A pesar del nombre no tiene relación con la sudoración excesiva como se pensaba antes.
- El curso es crónico y recidivante con brotes que pueden desencadenarse por alérgenos o estrés.
- Los corticoides tópicos de alta potencia como betametasona se usan desde el inicio del brote.
- Los casos graves o recurrentes pueden requerir corticoides orales o fototerapia.
- Identificar y evitar alérgenos y factores irritantes es fundamental para prevenir recaídas.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ECCEMA DISHIDRÓTICO)

PREGUNTA 1

¿Cuál es la localización característica de las vesículas del eccema dishidrótico?

- A)** Cara anterior de antebrazos y cuello en zonas de rascado crónico
- B)** Palmas de las manos, plantas de los pies y dedos bilateralmente
- C)** Cuero cabelludo y zonas seborreicas de la cara y el tronco
- D)** Zonas extensoras como codos y rodillas con patrón simétrico
- E)** Mucosas orales y genitales con vesículas que se erosionan rápido

PREGUNTA 2

¿Cuál es el tratamiento de primera línea durante un brote de eccema dishidrótico?

- A)** Antihistamínicos orales de segunda generación para controlar el prurito
- B)** Corticoides tópicos de alta potencia como betametasona desde el inicio del brote
- C)** Antifúngicos tópicos para tratar la sobreinfección por candida
- D)** Solo hidratación con crema emoliente sin ningún medicamento adicional
- E)** Inmunosupresores sistémicos como ciclosporina desde el primer brote

PREGUNTA 3

¿Por qué las vesículas del eccema dishidrótico son tan tensas?

- A)** Porque tienen un contenido hemorrágico a alta presión dentro de ellas
- B)** Porque se encuentran en la dermis profunda rodeadas de tejido fibroso
- C)** Porque están ubicadas en la capa córnea gruesa de palmas y plantas
- D)** Porque la inflamación genera un exudado con alta tensión superficial
- E)** Porque el estrés oxidativo genera un colágeno más rígido alrededor

RESUMEN: ECCEMA DISHIDRÓTICO

El eccema dishidrótico, también llamado pompholyx o dishidrosis, es una enfermedad inflamatoria crónica y recidivante de la piel que se caracteriza por vesículas muy tensas, profundas y muy pruriginosas localizadas en las palmas de las manos, las plantas de los pies y los dedos. A pesar de su nombre, no tiene relación con la sudoración, ya que su etiología real es una reacción inflamatoria en la que participan factores alérgicos, irritativos y de estrés. Las vesículas son tensas porque se ubican en la capa córnea gruesa de palmas y plantas. El prurito es intenso, uno de los síntomas más molestos para el paciente. La enfermedad tiene un curso crónico con brotes y remisiones. El tratamiento requiere identificar y evitar los alérgenos o irritantes desencadenantes. Los corticoides tópicos de alta potencia como la betametasona se indican desde el inicio del brote para controlar la inflamación. Los casos graves o recurrentes pueden requerir corticoides orales o fototerapia.